Министерство здравоохранения Московской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

ул. Дубки, влд. 7, стр.1 п. Здравница
г.о. Мытищи, Московская область, 141034
Тел. (495) 584-01-01
E-mail: mz_mokptd@mosreg.ru

29.07.2025 № 04-594/25

На № _____ от _____

Руководителям филиалов
ГБУЗ МО «МОКПТД»

Главным врачам медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия»

Информационное письмо.

С целью повышения контроля качества оказания медицинской помощи в амбулаторных отделениях ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» необходимо руководствоваться следующими алгоритмами:

- порядком проверки медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (Приложение 1, 2).

- алгоритмом обследования пациента в интенсивной фазе лечения туберкулёза (Приложение 3).

- алгоритмом обследование пациента в фазе продолжения при лечении туберкулёза (Приложение 4).

Данные алгоритмы и порядки должны использоваться в работе на постоянной основе врачами, заведующими отделениями и руководителями филиалов.

С уважением

Главный врач С.В. Смердин

Исп.: Баронова О.Д.
Тел.: 8-499-673-00-88

Приложение 1
к письму ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 29.07.2025 № 04-594/25

Порядок ведения медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях

1. *Оформление титульного листа формы №025/У, паспортные данные*

Титульный лист соответствует учетной форме № 025/У согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ **от 15 декабря 2014 г. N 834н** «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».

Необходимо проверить наличие следующих данных:

1.1. Обозначение юридического лица (адрес и название медицинской организации) верхний левый угол формы.

1.2. ФИО полностью без сокращений, число, месяц, год рождения пациента.

1.3. п. 5 адрес постоянной регистрации, адрес временной регистрации и адрес проживания.

1.4. п. 7; п. 8; п. 11 номера и серии следующих документов: страхового медицинского полиса с указанием даты выдачи полиса и названия страховой компании, СНИЛС, а также документа, удостоверяющего личность, где указаны сведения, когда и каким подразделением был выдан документ (полная информация).

1.5. № участка; № ФРБТ указываются в верхнем правом углу.

1.6. п. 6 – контактный телефон пациента и (или) телефон доверенного лица.

Примечание: копии паспорта, СНИЛС и др. документов приобщаются к амбулаторной карте только с письменного согласия пациента! Если копии документов приобщаются к амбулаторной карте, то на копиях делается запись, что копии сделаны с согласия пациента.

2. Клинический диагноз пациента, информированные согласия, извещения о взятии под диспансерное наблюдение в противотуберкулезной организации

2.1. Наличие клинического диагноза (т.е. заболевания, по поводу которого осуществляется диспансерное наблюдение) п.20 (ЕМИАС) с указанием кода по МКБ-10.

2.2. Обязательное внесение данных об аллергической реакции - перечень препаратов с описанием аллергических реакций и нежелательных реакций (п 23. на оборотной стороне формы 025/у).

2.3. Корешок извещения об установлении и прекращении диспансерного наблюдения в медицинской противотуберкулезной организации (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года N 127н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза и признании утратившими силу пунктов 16-17 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н». (Шаблон в ЕМИАС № 2145364).

2.4. Информированное добровольное согласие (ИДС) на медицинское вмешательство учетной формы приложения № 2 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2021 г. N 1051н “Об утверждении Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, формы информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства” (с указанием, кому пациент доверяет передачу информации о состоянии своего здоровья). Согласия должны быть заполнены, подписаны пациентом, либо законным представителем пациента, а также подписаны медицинским работником с расшифровкой ФИО.

В случае отказа от медицинских вмешательств или госпитализации на ИДС делается запись, о том, что пациенту разъяснены последствия его отказа от…в виде…и указывается, какой специалист проводил эту работу (Ф.И.О., должность).

2.5. Информированное добровольное согласие на обработку персональных Данных по форме, утвержденной Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 19.07.2021г. № 144-Р «Об утверждении форм информированных согласий на обработку и передачу персональных данных, а также на обработку и передачу специальных категорий персональных данных» (в ЕМИАС). Согласия должны быть заполнены, подписаны пациентом, либо законным представителем пациента, а также подписаны медицинским работником с расшифровкой ФИО.

2.6. Проверить согласие на постановку пробы с Диаскинтестом по форме, утвержденной приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» от 04.06.2025г. № 89/25 «О совершенствовании иммунодиагностики у взрослых».

Примечание: необходимо проверить разборчивость печатного текста в бланках согласий, отсутствие обрезки текста (сохранения полей) - возможна потеря качества при многократных копированиях бланков.

3.Соблюдение полноты записей в типовых шаблонах

3.1. Жалобы пациента

3.2. Направление на консультацию, при его отсутствии обязательно указывается «самообращение».

3.3. Анамнез заболевания с указанием эпидемического анамнеза (контакт с больными туберкулезом, длительно кашляющими, с больными ХНЗЛ, заболевание туберкулезом в прошлом и др.). Запись о наличии или отсутствии детей в очаге, их возраст, данные о семейных, производственных контактах и др. Отмечается перечень сопутствующих заболеваний, пребывание в учреждениях ФСИН, наличие вредных привычек.

3.4. Информация о том, каким специалистом из какой МО был направлен пациент, дата и обстоятельства выявления патологических изменении, пребыванием в учреждениях ФСИН, а также сведения о наличии группы инвалидности. Также уточняются сведения о предыдущем флюорографическом (рентгенологическом) обследовании, результатах лучевых методов дообследования с запросом выполненного флюорокадра (рентгенологического кадра) для пересмотра.
Указывается место работы и условия труда, наличие профессиональной вредности, принадлежность к декретированным контингентам, принадлежность к группам риска.

3.5. Клинико-экспертный анамнез заполняется в том числе и в случае, если пациент не работает. Обращается внимание на наличие листка нетрудоспособности на момент первичной явки.

3.6. Информация о перенесенных инфекционных заболеваниях, переливание крови и кровезамещающих жидкостей. Пребывание за пределами региона, за рубежом в последние 6 месяцев.

3.7. Результаты иммунодиагностики. Бактериограмма - вносятся все имеющиеся результаты анализа мокроты, в том числе из стационара, всеми методами. Другие результаты лабораторных и инструментальных методов обследования.

3.8. Данные объективного осмотра с отражением тяжести состояния пациента.

3.9. Наличие предварительного диагноза (до решения ВК о взятии под диспансерное наблюдение).

Примечание: предварительный диагноз должен быть обоснован.

Пример: «На основании жалоб (кашель с мокротой, подъемы температуры до 38^0 в вечернее время), положительного результата пробы с АТР, инфильтративных изменений в С1-2 правого легкого, выявленных при профилактическом осмотре, на фоне отрицательных результатов люминесцентной микроскопии от «__»_____, сформирован клинический диагноз: «Инфильтративный туберкулез С1-2 правого легкого», МБТ(-).

3.10. Наличие сведений о лучевой нагрузке.

Приложение 2
к письму ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 29.07.2025 № 04-594/25

Порядок оформления документации при взятии под диспансерное наблюдение и дальнейшем диспансерном наблюдении пациента

1. *Эпикриз с заключением ВК о взятии под диспансерное наблюдение* соответствует форме приложения №2 приказа ГБУЗМО «МОКПТД» №18/22 от 18.01.2022г. или из ЕМИАС

1.1.Диагноз в решении ВК оформляется с указанием формы процесса, локализации, фазы, наличия бактериовыделения, известной лекарственной устойчивости возбудителя, осложнений, сопутствующей патологии в соответствии с клинической классификацией (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003г. N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации"). Указывается группа диспансерного наблюдения, режим химиотерапии. Обоснование клинического диагноза, подробное и последовательное, основывается на данных анамнеза, жалобах, результатах объективного обследования, результатах лабораторных, рентгенологических,
инструментальных и других исследованиях (сокращения не допускаются). Также указывается дата проведения ЦВК.

Обязательны подписи лечащего врача и заведующего отделением с расшифровкой подписей.

1.2. Проверяется срок установки клинического диагноза не более 14 дней.

1.3. В протоколе ВК отражается схема лечения с указанием доз в случае амбулаторного лечения и план ведения пациента. Дата ВК о постановке на учёт должна совпадать с датой подачи извещений (058/у и 089/у) и диагнозом в листе уточненных диагнозов.

1.4. В случае выявления бактериовыделения любым методом после постановки на учёт оформляется протокол ВК с решением о постановке на бациллярный учет, проверяется факт подачи повторно ф 058/у. О наличии бактериовыделения, вносятся изменения в выделенную графу журнала (ф.№ 60-у «Журнал учета инфекционных заболеваний») и в лист уточненных диагнозов.

1.5. В амбулаторной карте должна быть указана дата госпитализации. Делаются ежемесячные записи о пациенте, продолжающем лечение в стационаре.

1.6. Организация работы в очаге туберкулезной инфекции проводится в соответствии с Приложением № 12 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003г. N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации".

Посещение очага любого типа (независимо от отсутствия или наличия бактериовыделения) проводится в сроки не позднее 3-х суток с момента взятия пациента под диспансерное наблюдение.

2. *При выписке из стационара* оформляется эпикриз на ВК для продолжения лечения в амбулаторных условиях, где указывается клинический диагноз при выписке из стационара, дата выписки, достигнутые результаты, рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению пациента. В случае внесения изменений в схему лечения на стационарном этапе указываются причины замены препаратов. При наличии данных о непереносимости лекарственных препаратов эти сведения отмечаются в эпикризе и вносятся п. 23 на оборотной стороне титульного листа амбулаторной карты - формы 025/у. Также указываются причине выписки из стационара. Клинический диагноз оформляется с указанием основного заболевания, сопутствующего и осложнений. В плане ведения пациента отражаются рекомендации хирургов (торакального или специалистов по внелегочным локализациям).

3. *Ведение дневниковых записей наблюдения пациента на амбулаторном этапе* (1 раз в 7 дней; чаще - при необходимости)

3.1. Наличие жалоб (с детализацией).

3.2. Полнота объективного осмотра в том числе с указанием АД, ЧСС, ЧДД.

3.3. В дневниковых записях должны быть отражены результаты предыдущих лабораторных и инструментальных исследований и их интерпретация в случаях отклонения от нормы. Также делается запись, что пациент ознакомлен с результатами обследования.

3.4. Наличие развернутого клинического диагноза в соответствии с клинической классификацией с указанием формы процесса, локализации, фазы, наличия или отсутствия бактериовыделения, лекарственной устойчивости возбудителя, осложнений и диагноза сопутствующего заболевания (сокращения не допускаются).

3.5. Назначение дополнительных методов исследований. Объемы назначений лабораторных и инструментальных методов исследования, их кратность должны соответствовать клиническим рекомендациям.

3.6. Проверяется кратность направления пациентов к специалистам соответствующего профиля в соответствии с клиническими рекомендациями и в зависимости от сопутствующей патологии.

3.7. Обязательно своевременное представления на ВК после завершения текущего этапа лечения.

3.8. При назначение лекарственных средств указывается доза препарата, способ введения, кратность и время приема, связь с приемом пищи, указывается количество выданных препаратов.

Например, «Изониазид» 300мг №20 по 2 таблетки перорально утром один раз в день, через час после завтрака в 9-00.

3.9. Обязательно должна быть указана дата следующей явки на прием!

3.10. Подпись лечащего врача и расшифровка подписи.

4. Наличие протоколов ВК в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, согласно дате проведения должно быть в следующих случаях:

4.1. Взятие пациента под диспансерное наблюдение, снятие пациента с диспансерного наблюдения.

4.2. Перевод в другую группу диспансерного наблюдения.

4.3. После окончания интенсивной фазы лечения, перевода на фазу продолжения.

4.4. При необходимости продление фазы лечения, свыше срока, установленного решением предыдущей ВК.

4.5. ВК при внесении каких-либо изменении в схему лечения, при замене лекарственных препаратов в схеме лечения (либо в связи с развитием нежелательных явлений, подтвержденных клиническими проявлениями и лабораторными анализами, либо в случае отсутствия препарата в аптеке, что обязательно надо указать!), при смене режима химиотерапии.

4.6. Появления полости распада или бактериовыделения, внесение изменения в листе уточнения диагнозов.

4.7. ВК после выписки из стационара пациента, получающего лечение по лекарственно-чувствительным или лекарственно-устойчивым режимам с включением дорогостоящих противотуберкулезные препараты, требующие количественного списания, назначение 5 и более препаратов.

4.8. В протоколах ВК необходимо наличие подписей не менее 3-х членов ВК (ЭЛДП, ЭВН) с указанием номера и даты оформления протокола. Обязательно!

4.9. При назначении профилактического лечения лицам из групп высокого риска развития туберкулеза (контакт с больным туберкулезом, ЛТИ и др.).

4.10. ВК при направлении на МСЭ. Оформление формы 088/у при первичном и повторном направлении на МСЭ.

4.11. ВК в случае выдачи, продление листка нетрудоспособности свыше 15 дней.

4.12. Допуск к труду или к учебе; разрешение нахождения в детском коллективе при оформлении академического отпуска и др.

4.13. Разбор жалоб. Разбор случаев смерти.

5. Виды эпикризов в медицинской карте амбулаторного больного согласно приказа ГБУЗ МО «МОКПТД» от 28 июля 2022 года № 217/22 «Об алгоритме контроля за оформлением и ведением медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», приказа ГБУЗ МО «МОКПТД» от 31 мая 2024 года № 129/24 «Об организации амбулаторной помощи на дому и внесении изменений при оформлении и ведении медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях».

5.1. Эпикриз при продолжении лечения в амбулаторных условиях после стационарного этапа;

5.2. Этапный эпикриз при переводе пациента из интенсивной фазы в фазу продолжения лечения (Шаблон в ЕМИАС № 2173656);

5.3. Годовой эпикриз;

5.4. Эпикриз передачи пациента на курацию другому врачу на период трудового отпуска лечащего врача (Шаблон в ЕМИАС № 2179289).

6. Организация работы в ЕМИАС

6.1. Сведения о каждом посещении пациента вносятся в ЕМИАС в день непосредственного посещения пациентом амбулаторного отделения.

6.2. Каждое посещение вносится как первичное, вид услуги - «ОМС», дата в талоне амбулаторного пациента (ТАП) и дата дневниковой записи должны строго соответствовать! В ТАПе и дневниковой записи клинический диагноз должен совпадать!

6.3. В один календарный день посещение врача-фтизиатра участкового одного филиала и врача-фтизиатра другого филиала или КДО не должны оформляться, так как учитывается только одно посещение врача-фтизиатра!

6.4. Посещение пациента амбулаторного отделения соответствует расписанию в ЕМИАС.

Примечание: если пациент принимается врачом в порядке живой очереди и в расписании отсутствуют свободные ячейки для записи, то формируются дополнительные ячейки для записи.

6.5. Телемедицинские консультации в рамках видеоконтролируемого лечения оформляются как первичное посещение (Шаблон в ЕМИАС № 2096838), вид услуги - «ОМС». В ЕМИАС заранее могут создаваться ячейки ТМК в ЕМИАС, при их отсутствии – в день проведения ТМК. Видеоконтроль за лечением регламентирован приказом ГБУЗ МО «МОКПТД» от 14.07.2023г. № 197/23 «О внедрении дистанционного контроля за проведением химиотерапии туберкулеза, химиопрофилактики, превентивного лечения туберкулеза у лиц с латентной туберкулезной инфекцией в ГБУЗ МО «МОКПТД».

Приложение 3
к письму ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 29.07.2025 № 04-594/25

Алгоритм обследования пациента в интенсивной фазе лечения туберкулёза

Режимы лечения / Обследования	Перед назначением курса ХТ	**Режимы ЛЧ-ТБ, Н-резистентного ТБ**	**Режимы МЛУ-ТБ, Пре ШЛУ-ТБ, ШЛУ- ТБ**
Общий анализ крови, биохимический анализ крови (общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, общий билирубин, глюкоза) Общий анализ мочи, исследование мокроты на МБТ (бактериоскопия, посев на ППС)	ОАК, ОАМ, Биохимический анализ крови, Исследование мокроты на МБТ методами люминесцентной микроскопия + ЖПС+ ППС+МГМ	не реже 1 раза в месяц	Не реже 1 раза в месяц
Исследование мочевой кислоты	1 раз до назначения Z	Не реже 1 раза в месяц при лечении пиразинамидом (Z)	Не реже 1 раза в месяц при лечении пиразинамидом (Z)
Исследование уровня калия	МЛУ-ТБ, пре-ШЛУ ТБ, ШЛУ -ТБ	-	Не реже 1 раза в месяц
Исследование уровня альбумина при лечении деламанидом (Dlm)	Перед назначением Dlm	-	Не реже 1 раза в месяц при лечении Dlm
Исследование уровня ТТГ Трр	Перед назначением Трр	-	Не реже 1 раза в 2 мес при лечении Трр
ЭКГ	Перед началом лечения с расчетом QT	Не реже 1 раза в месяц	Не реже 1 раза в месяц с расчетом QT
Компьютерная томография (рентгенографическое исследование)	Перед началом лечения	Не реже 1 раза в 2 месяца	Не реже 1 раза в 2 месяца
Осмотр офтальмолога	1 раз (до назначения Е и/или Lzd	не реже 1 раза в месяц при лечении Е и/или Lzd	не реже 1 раза в месяц при лечении Е и/или Lzd
Осмотр оториноларинголога, аудиограмма	1 раз (до назначения Km, Am, Cm)	не реже 1 раза в месяц при назначении Km, Am, Cm)	не реже 1 раза в месяц при назначении Km, Am, Cm)
Осмотр невролога	1раз (до назначения Lzd)	-	По показаниям
консультация торакального хирурга	через 2 месяца от начала ХТ, через 4 месяца от начала ХТ, в конце ИФ при отсутствии положительной динамики, выявление жидкости в плевральной полости или перикарде		

* при одновременном назначении трех и более кардиотоксичных препаратов ЭКГ выполняют 1 раз в 5 дней в течении месяца, далее 2 раза в месяц.

Приложение 4
к письму ГБУЗ МО «МОКПТД»
от 29.07.2025 № 04-594/25

Алгоритм обследование пациента в фазе продолжения при лечении туберкулёза

Режимы лечения / Обследования	**Режимы ЛЧ-ТБ, Н-резистентного ТБ**	**Режимы МЛУ-ТБ, Пре ШЛУ-ТБ, ШЛУ- ТБ**
Общий анализ крови, биохимический анализ крови (общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, общий билирубин, глюкоза) Общий анализ мочи, исследование мокроты на МБТ (бактериоскопия, посев на ППС)	не реже 1 раза в 3 месяца	Не реже 1 раза в 3 месяца
Исследование мочевой кислоты	Не реже 1 раза в 2 месяца при лечении пиразинамидом (Z)	Не реже 1 раза в 2 месяца при лечении пиразинамидом (Z)
Исследование уровня калия	-	Не реже 1 раза в 2 месяца
Исследование уровня альбумина при лечении деламанидом (Dlm)	-	Не реже 1 раза в месяц при лечении Dlm
Исследование уровня ТТГ Трр	-	Не реже 1 раза в 2 мес при лечении Трр
ЭКГ	Не реже 1 раза в 3 месяца	Не реже 1 раза в месяц с расчетом QT
Компьютерная томография (рентгенографическое исследование)	Не реже 1 раза в 2 месяца	Не реже 1 раза в 2 месяца
Осмотр офтальмолога	не реже 1 раза в месяц при лечении Е и/или Lzd	не реже 1 раза в месяц при лечении Е и/или Lzd
Осмотр оториноларинголога, аудиограмма	не реже 1 раза в месяц при назначении Km, Am, Cm)	не реже 1 раза в месяц при назначении Km, Am, Cm)
Осмотр невролога	-	По показаниям
Консультация торакального хирурга	при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики (сохранение/появление бактериовыделения, сохранение полости распада)	

* при одновременном назначении трех и более кардиотоксичных (бедаквилин, моксифлоксацин, левофлоксацин, спарфлоксацин, деламанид) препаратов ЭКГ выполняют 1 раз в 5 дней в течении месяца, далее 2 раза в месяц.